

1 実践チェックリスト(保険薬局/病院)

保険薬局薬剤師

- ☐ 膵酵素製剤の服用タイミング・量と脂肪便・体重の確認
- ☐ オピオイドのレスキュー回数・便秘・眠気の確認
- ☐ 電話フォローで発熱・寒気・黄疸・下痢を確認
- ☐ 他院の睡眠薬・市販薬を含めた併用薬の確認
- ☐ 疼痛・症状をトレーシングレポートで病院へ共有

病院薬剤師

- ☐ 全身状態・gBRCA・UGT1A1とレジメンの整合性の監査
- ☐ FOLFIRINOXの減量(modified)とG-CSF予防の設定
- ☐ 疼痛・胆管炎など症状悪化時の院内連携(緩和ケア・消化器)
- ☐ 携帯型ポンプの準備と外来化学療法室での説明
- ☐ お薬手帳へのレジメン情報・投与日の記載

病院と共有する情報

レジメン・胆道ステント

検査値

疼痛の強さ・レスキュー

食事量・体重・黄疸

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

レジメン・薬剤	構成・投与スケジュール	周期	薬局での確認ポイント
modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン+イリノテカン+レボホリナート →5-FU 46時間持続静注(急速静注は省略)	2週毎	携帯型ポンプ、G-CSF予防、UGT1A1、下痢・しびれ
GEM+nab-PTX	ゲムシタピン+ナブパクリタキセル 1・8・15日目	4週毎	骨髄抑制、末梢神経障害、脱毛、発熱
ゲムシタピン単剤	1・8・15日目	4週毎	投与当日～翌日の発熱・倦怠感、骨髄抑制、間質性肺炎
S-1単剤	4週服用・2週休薬(術後補助は6か月)	6週毎	腎機能に応じた用量、下痢・口内炎、他のフッ化ピリミジン系は併用禁忌
nal-IRI+5-FU/LV	イリノテカンリボソーム製剤+レボホリナート+5-FU 46時間	2週毎	遅発性下痢、好中球減少、UGT1A1
オラパリブ	300mg 1日2回 連日内服(維持療法)	連日	貧血(定期的な血液検査)、悪心、CYP3A阻害薬・誘導薬

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌	イリノテカン UGT1A1阻害	処方薬 アタザナビル(抗HIV薬)	SN-38 ↑ → 骨髄抑制・下痢が重篤化	併用しない。他院処方をお薬手帳で確認
禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カベシタピン・5-FU等)	5-FU濃度 ↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意	オラパリブ CYP3A阻害・誘導	処方薬 クラリスロマイシン・リファンピシン等	副作用 ↑ ・効果 ↓	他院の抗菌薬・抗結核薬の処方を確認
注意	オピオイド 中枢抑制の重複	処方薬 睡眠薬・抗不安薬(他院処方)	過鎮静・呼吸抑制・転倒	他院の睡眠薬・抗不安薬を確認
注意	S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR ↑ (出血)・フェニトイン中毒	INR測定の頻度を処方医と確認
確認	オピオイド 便秘対策の不足	市販薬 市販の刺激性下剤・下剤の未使用	便秘の遷延・腸閉塞	下剤の処方と市販薬の使用状況を確認

4 服薬指導の声かけ例と確認のタイミング

治療開始前

「消化酵素のお薬は食事のすぐ後に飲むと、脂っぽい便や体重減少を防ぎやすくなります」

確認:お薬手帳で全身状態・gBRCA・UGT1A1、胆道ステントの有無

△ 皮膚や白目が黄色い(黄疸)時は至急連絡

投与後～5日

「下痢止めや吐き気止めは指示どおりに。ゲムシタピン後の発熱は一時的なことが多いですが、続く時は連絡を」

確認:電話フォローで下痢・水分量、携帯型ポンプの抜針、G-CSFの予定

△ 水様便が止まらない・水分がとれない時は至急連絡

投与後1～2週

「37.5℃以上の熱が出たら、解熱剤で様子を見ずに、すぐ病院へ連絡してください」

確認:電話フォローでnadir期の発熱・寒気、食事量

△ 発熱+寒気は胆管炎・FNを疑い至急受診

次回来局時

「痛み止めは効いていますか。便秘や眠気、手足のしびれで困っていることはありませんか」

確認:疼痛の強さ・レスキュー回数、便秘、体重、しびれ

△ 痛みの急な増強・便が出ない状態が続く時は連絡